

50 - 03-Splénomégalie - Pr. K. KRATI

(0:01 - 0:50)

L'asthménomégalie, c'est une augmentation du volume de la rate. Ça se voit dans des pathologies variables et nombreuses, et c'est pour ça qu'il faut la connaître et surtout connaître les différentes stratégies à suivre pour établir le diagnostic étiologique. Nous allons donc traiter ce chapitre selon le plan suivant, après l'introduction et les rappels anatomiques et physiologiques, nous parlerons des moyens diagnostiques et comment faire le diagnostic différentiel, nous décrirons la stratégie à suivre dans le diagnostic étiologique et nous parlerons des principes thérapeutiques avant de conclure.

(0:53 - 1:27)

L'étudiant donc doit être capable de reconnaître l'asthmémégalie et être capable de la rechercher par l'examen clinique. Il doit donc la distinguer de toutes les autres masses de l'hypochondrocoche qui ne sont pas en rapport avec l'augmentation de la taille de la rate. Il doit préciser, être capable de préciser les caractères de l'asthmémégalie, surtout de mener une enquête étiologique devant une asthmémégalie et reconnaître les principales causes d'une asthmémégalie.

(1:30 - 2:19)

L'asthmémégalie, comme je l'ai dit, c'est une augmentation de volume de la rate, il faut savoir que la rate n'est jamais palpable à l'examen clinique et toute rate palpable doit être considérée comme une asthmémégalie. Le diagnostic repose essentiellement sur la clinique, mais parfois on a des petites asthmémégalies qui ne peuvent pas être détectées par la clinique et donc l'échographie permet le diagnostic. J'insisterai sur le caractère varié et multiple des causes de l'asthmémégalie qui peuvent être digestives ou extra-digestives, de l'intérêt de mener une enquête étiologique bien adaptée pour arriver rapidement au diagnostic.

(2:22 - 4:25)

La rate est située dans la loge phrénique, gauche, elle a un diamètre antéropostérieur de 8 à 12 cm et un diamètre transversal de 4 à 8 cm, elle a des rapports en haut avec la coupole diaphragmatique, en arrière avec l'angle coulic et le rein gauche et en dedans avec la queue du pancréas et la grande courbure gastrique. Il joue un rôle physiologique dans diverses situations, déjà il faut savoir que la rate a une vascularisation très particulière, la rate est drainée par la veine splénique qui reçoit la veine mésentérique inférieure et qui va constituer le plan splénorail qui va former la veine porte avec la veine splénique, avec la veine mésentérique supérieure et la veine porte va assurer la vascularisation de la veine du foie. Tout ceci pour dire que cette vascularisation particulière fait que la rate est sensiblement liée au drainage portale, donc en cas d'hypertension portale, il peut y avoir une stase au niveau du système porte et par

conséquent au niveau de la veine splénique qui va entraîner une augmentation, une hypertrophie de la rate, cette hypertrophie de la rate a pour conséquence d'augmenter son activité, ce qui serait à l'origine d'un hypersplénisme, cet hypersplénisme peut entraîner donc une diminution des éléments figurés du sang, à savoir les plaquettes, les globules blancs et les héoglobules, les globules rouges, et donc c'est pour ça que l'asthme splénorégalique fait partie des signes d'hypertension portale.

(4:27 - 6:00)

Comme je l'ai dit, la rate joue un rôle très important, elle a différents rôles, entre autres le rôle immunitaire, au niveau de la rate il y a la phagocytose de tous les éléments figurés du sang qui sont anormaux, en particulier des globules rouges, et c'est pour ça que l'hémolyse peut s'accompagner, donc en cas d'hémolyse, il peut s'accompagner d'une splénomégalie, il peut y avoir aussi les phagocytoses de certaines bactéries, de certains virus, donc c'est pour ça qu'il peut être augmenté dans certaines infections et septicémies, comme la rate, c'est un passage obligatoire du sang, et donc on peut avoir des dépôts en cas de certaines maladies de surcharge. Il joue aussi un rôle dans la maturation des lymphocytes, donc il a un rôle hématopoïétique pendant la vie totale, et il peut essentiellement, et il peut être donc aussi atteint lors des hémorragies. Il faut savoir que la rate aussi c'est un milieu de stockage de fer, des plaquettes, du facteur 5, des globules rouges, et donc là aussi, toute perturbation de ces éléments là aurait un impact sur le fond, pardon, sur la rate.

(6:05 - 6:55)

Le diagnostic positif de la splénomégalie peut être fait dans des circonstances variables, par exemple, de façon forte, vite, en l'absence ou devant des signes qui sont peu spécifiques, notamment une douleur de l'hypochondrocoche qui peut être atypique de pesanteur, soit en rapport avec une compression des organes de voisinage, une dyspepsie, une constipation, soit par une complication de la splénomégalie. C'est des situations qui sont rares. Parfois, la splénomégalie peut s'accompagner d'un infarctus clinique qui serait à l'origine d'une douleur paroxystique ou d'un hématome surcapsulaire avec une sensation de pesanteur et donc qui va amener le malade à consulter, à faire l'échographie.

(6:55 - 10:04)

Il peut aussi être révélé par des signes en rapport avec l'étiologie, notamment avec des signes en rapport avec l'hypertension portale ou avec une hémopathie, donc des adénopathies périphériques lors d'un bilan des adénopathies ou devant un syndrome infectieux. Comme le malade peut faire une échographie de façon en l'absence de signes d'appel vers la rate et on découvre donc une splénomégalie. L'examen clinique déjà à l'inspection, lorsqu'on a une rate qui est une splénomégalie importante, il peut être à l'origine d'une rosure de l'hypochondrocoche avec un bord grenellé comme on le voit chez cet enfant.

Cet aspect-là n'est pas toujours retrouvé. Parfois l'inspection, je dirais même souvent, peut être normale. Donc comment rechercher la sphénomégalie? En fait, la sphénomégalie, elle est recherchée essentiellement par la palpation qui permet d'abord de rechercher son bord antérieur grenellé.

Donc le patient, on va la rechercher de deux manières, soit que le patient est en déquibitus dorsal. L'examineur, lui, il est à droite. Il va placer sa main droite à plat et de façon perpendiculaire aux dernières côtes et on va rechercher le bord antérieur qui va buter contre l'extrémité des doigts lors de l'inspiration profonde.

Donc on va commencer un petit peu plus en bas et on va remonter avec la main en essayant d'accueillir ce bord qui va venir buter contre le bras. Cette recherche se fait avec une palpation profonde, parfois main sur main et de façon douce et on va rechercher la sphénomégalie. Lorsque la sphénomégalie n'est pas très importante, il est parfois difficile de retrouver ce bord grenellé.

Donc on demande au malade de se mettre en déquibitus latéral droit avec la jambe gauche fléchie pour relâcher un petit peu la paroi abdominale et l'examineur va mettre ses doigts encrochés sous le rebord costal gauche et à ce moment-là, on demande au malade de faire une inspiration profonde, à ce moment-là, il va percevoir le bord inférieur de la rate lors de cette inspiration profonde. Donc on dit qu'il y a une pointe de rate. Donc toute rate palpable est dite sphénomégalie.

(10:09 - 11:31)

Si on arrive à dessiner le débord sphénique, on peut mesurer la sphénomégalie. On peut la dessiner de façon entre le rebord costal et le débord sphénique sur la ligne mamelonnaire gauche et ça permet dans certaines situations de suivre l'évolution de la sphénomégalie envers certaines pathologies. La percussion permet de délimiter ou de préciser plutôt le bord supérieur parce que la rate est mat et elle est en contact avec les poumons et l'angle colicoche qui est sonore.

Ça nous permet de rechercher cette limite, ce bord supérieur, mais il n'a pas un impact en pratique qui est important parce que toute rate palpable est considérée comme pathologique. Donc c'est une sphénomégalie et elle a la même signification. Donc l'intérêt de mesurer la flèche sphénique n'a pas de place en pratique ligne.

(11:32 - 13:13)

Bien sûr, il faut rechercher un souffle qui peut orienter vers une origine vasculaire. L'échographie, c'est un examen paraclinique, anodin, non invasif, disponible, qui a un intérêt dans le diagnostic positif de la sphénomégalie et il permet de mesurer la rate. On parle sur le plan échographique d'une sphénomégalie lorsque le grand axe est supérieur à 14 cm.

L'acclinique et l'échographie permettent d'éliminer tout ce qui peut entraîner une masse au niveau de l'hypocondre ou du flanc gauche et qui n'est pas une masse qui est très importante. Le diagnostic étiologique, il repose sur l'enquête d'abord clinique par l'interrogatoire qui doit préciser l'âge. Donc en fait, l'âge est très important.

Si je gère une sphénomégalie, je dois plus rechercher les ennemis hémolytiques constitutionnels. Je ne suis pas capable d'éliminer tout ce qui est tumoral, hypertension portale. Il faut rechercher aussi l'origine éthique.

(13:14 - 15:28)

Certaines maladies infectieuses qui s'accompagnent de sphénomégalie se voient dans certaines régions plus que d'autres. Il faut rechercher une cardiopathie, une valvulopathie, c'est très important. Toute sphénomégalie chez un patient qui a une valvulopathie doit faire craindre une endocardite.

Il faut rechercher un voyage en zone d'endémie de certaines maladies, notamment de paludisme, même s'il est très, très ancien ce voyage. Il faut rechercher un contexte de tuberculose. La tuberculose clinique peut aussi se manifester par une sphénomégalie.

Il faut rechercher la notion de géophagie chez des patients qui ont des antécédents de géophagie, en particulier dans l'enfance, peuvent faire des anémies sideropéniques avec des sphénomégales. Il faut rechercher des antécédents dictaires de tumeurs primitives connues qui doivent faire craindre une décimation de leur maladie. Il faut rechercher un contexte infectieux viral.

Plusieurs virus peuvent s'accompagner de sphénomégales, infections des races accompagnées de sphénomégales, notamment l'Epstein-Barr virus, les hépatites virales, les virus des hépatites virales, l'HIV, etc. Il faut rechercher aussi des signes en faveur d'un contexte infectieux, des signes en faveur d'un contexte infectieux, par exemple, des signes de l'hypertension portale ou d'autres localisations de tuberculose comme la localisation chloro-pulmonaire, par exemple. L'examen clinique est très important.

Il va nous permettre de retrouver d'abord la sphénomégalie, de préciser ce qui est modulaire, de préciser est-ce qu'elle est importante, est-ce qu'il descend jusqu'au pelvis? Donc, ça, c'est très important. Il doit rechercher des signes associés qui sont très importants. En particulier, il faut rechercher une pâleur cutanioniqueuse, donc qui est en faveur d'une anémie.

(15:29 - 15:46)

Il doit rechercher aussi ce qu'il y a de la fièvre. Donc, fièvre, plus que l'homégalie, c'est une ondocardie, c'est la preuve du cancer, ou une céliacémie. Il faut rechercher aussi s'il a un syndrome hémorragique cutané, s'il y a une altération de l'état général.

(15:46 - 16:07)

Il faut rechercher les signes d'hypertension portale, à savoir l'acide, la circulation collatérale. Il faut rechercher les signes d'insuffisance hépatocellulaire, des enjambes stellaires, des retrousses palmoplantaires, un nectaire. Il faut rechercher s'il est associé à une céronomie d'homégalie, à une hépatomégalie.

(16:07 - 16:25)

Ça se voit aussi bien dans le syndrome d'hypertension portale liée au rapport avec une cirrhose ou dans certaines hémopathies. Il faut rechercher les adénopathies périphériques pour faire un examen des herbes ganglionnaires. Bien sûr, il faut faire un examen cardiovasculaire, rechercher éventuellement un souffle.

(16:26 - 16:50)

Et il faut rechercher, faire un examen complet, cutané des herbes ganglionnaires, appareil par appareil, pour rechercher des signes au faveur d'une maladie générale. Au terme de ce bilan, déjà, on peut avoir une orientation. Et le bilan initial qu'il faut demander, c'est une numération formule 108.

(16:51 - 16:58)

La numération formule 108 peut donner beaucoup de renseignements. Il peut montrer déjà une anémie. Ça, c'est très important.

(16:58 - 17:19)

Il faut donc préciser ses caractères et rechercher s'il n'y a pas une anémie inutile qui peut être constitutionnelle ou auto-humaine. Il faut aussi s'intéresser aux globules blancs et leurs formules. On peut avoir une locopénie, une hyperlococytose.

(17:19 - 17:36)

On peut avoir une neutropénie, une hyperosinophilie, etc. Il faut rechercher. Il faut aussi préciser s'il n'y a pas une myélémie associée, s'il n'y a pas de blastose, parce que c'est très important, ces éléments-là.

(17:36 - 17:57)

La présence, par exemple, d'une blastose périphérique va nous orienter vers une leucémie aiguë. La présence d'une myélémie, déjà, va nous faire penser à une leucémie myeloïde chronique. Donc, la numération formule sanguine en elle-même peut déjà nous orienter vers une idéologie.

(17:57 - 18:11)

Le frottis sanguin est très important parce qu'il va montrer l'aspect des globules rouges. Il peut déjà nous orienter vers certaines anomalies congénitales des globules rouges. Il peut aussi montrer s'il y a des anomalies.

(18:12 - 18:46)

La route est faite doit être toujours demandée chez un patient qui a des antécédents de séjour dans un endroit où le paléodysme est vu de façon endémique ou devant une fièvre importante inexpliquée. Il faut rechercher systématiquement un syndrome inflammatoire par la vitesse de sédimentation et le dosage de la protéine séréactive. Il faut demander les sérologies achivées chez les patients à risque ou ayant des facteurs de risque.

(18:47 - 19:06)

Et bien sûr, l'échographie doit être systématique. L'échographie abdominale permet déjà de préciser les caractères de la sphenomégalie. Est-ce que c'est une sphenomégalie homogène ou nodulaire? Est-ce qu'il y a un abcès splénique? Est-ce qu'il y a une lésion cystique intrasplénique? Donc, ça, c'est important.

(19:06 - 19:32)

Il peut aussi montrer des signes d'hypertension portale, à savoir la dilatation du trompe-porte, la circulation portocave collatérale. Il peut aussi rechercher des signes en faveur d'une atteinte hépatique, donc une hépatomégalie. Il peut montrer soit des signes en faveur d'une surose, d'un froidissement fluide.

(19:33 - 20:04)

Il peut aussi montrer s'il y a une acide ou s'il y a des adénopathies profondes. En général, la clinique, avec ce bilan initial, peut nous orienter vers un diagnostic que l'on demandera à les examiner pour le confirmer. Parfois, ce bilan initial peut être insuffisant ou il peut orienter vers un diagnostic qu'il faut confirmer.

(20:05 - 20:28)

Donc, ce qui nous amène au bilan de deuxième intention. Donc, je commencerai par l'écho-coeur. En fait, l'echo-coeur, il peut être un bilan de deuxième intention comme il peut être aussi un bilan de première intention chez tous les patients qui sont fébriles ou qui ont connu porteur d'une valvulopathie ou chez qui on trouve à l'examen clinique un souffle cardiaque.

(20:29 - 21:09)

Parce que l'endocardite, l'endocardite bactérienne, c'est une urgence thérapeutique. Et si on ne

la traite pas en urgence, le pronostic vital du patient peut être mis en jeu. Je répète, l'écho-cœur, il peut être demandé en deuxième intention lorsque le bilan de première intention est négatif, qu'il ne permet pas d'orienter, comme il peut être demandé en première intention si on a un risque chez le patient d'avoir une endocardite.

(21:10 - 21:29)

Donc, quelle est cette situation? Chez tous les patients qui ont une valvulopathie sphénomégaly, il faut faire le cœur et rechercher les végétases. C'est tous les patients qui ont la sphénomégaly avec un souffle cardiaque. Chez tous les patients qui ont une sphénomégaly avec un syndrome fébrile, il ne faut pas hésiter ou retarder le cœur.

(21:30 - 22:03)

Le myélogramme sera demandé lorsqu'on a une anomalie au niveau de la numération 4000 v. Il permet d'étudier la richesse au niveau de la moelle, de rechercher un éventuel envahissement tumoral de la moelle et donc de rechercher. Il y a aussi des éléments infectieux, un organisme infectieux qui est au niveau de la moelle. La ponction biopsychiostéomédullaire sera demandée, bien sûr, en fonction du contexte.

(22:03 - 22:19)

Si on a une orientation et on suspecte une atteinte médullaire. Les sérologies, là aussi, seront demandées en fonction du contexte. Comme je l'ai dit, les sérologies virales seront demandées chez les sujets à risque ou ayant des facteurs de risque de ces infections.

(22:22 - 22:51)

Les recherches d'une tuberculose, lorsqu'on aura soit une sphénomégaly modulaire, soit des signes d'imprégnation de tuberculose ou d'autres localisations de tuberculose. La Bruxelles sera demandée chez un patient qui a une fièvre importante avec un contact avec les animaux. Il y a aussi les causes parasitaires qui seront, bien sûr, demandées en fonction de l'aspect étiologique et du contexte.

(22:56 - 23:23)

L'électrophorèse des protéines doit être demandée à la recherche chez un patient qui a un syndrome donc inflammatoire. Il doit rechercher une hypergammaglobulinémie qui peut se voir dans la Lichemognose ou une hypogammaglobulinémie qui doit nous faire orienter une hémopathie ou il faut rechercher un bloc pétégamma qui est en faveur d'une sérose. Les hémocultures seront toujours demandées chez des patients qui ont une fièvre.

(23:24 - 23:43)

Le bilan hépatique permet de rechercher donc une hépatopathie associée. Il comporte donc le dosage des enzymes hépatiques, notamment le transaminase, le phosphatase alkyl, les gammagétés et la bilirubine. D'autres examens seront demandés, bien sûr, en fonction du contexte.

(23:43 - 23:58)

Par exemple, si le patient présente des adénopathies périphériques, il faut les biopsies. Si le malade a une atteinte hépatique, on peut faire une fonction de biopsie hépatique. Donc, en fonction du contexte, nous pouvons demander d'autres examens complémentaires.

(24:02 - 24:45)

Les étiologies, je commencerai par les splénomégalies d'origine hématologique parce que c'est les plus fréquentes. Les causes hématologiques sont nombreuses, mais je me contenterai de parler de l'anémie, de citer l'anémie hémolytique qui peut être congénitale ou autoimmune et toutes les hémopathies infiltratifs, que ce soit un syndrome myeloprolifératif, comme les leucémies myélochroniques ou la maladie de Faguet, ou des syndromes lymphoprolifératifs comme la leucémie lymphocytaire chronique ou les leucémies aiguës myéloïdes ou lymphomes. La deuxième cause qui est aussi fréquente et très fréquente, c'est le syndrome d'hypertension portale.

(24:46 - 25:10)

Donc, le syndrome d'hypertension portale, le diagnostic est facile. Déjà, il y aura des signes échographiques qui que j'ai déjà cité, les varices œsophagiennes et nos hépatopathies souvent associées. Donc, le syndrome d'hypertension portale peut être en rapport avec un bloc suprahépatique ou intrahépatique ou intrahépatique.

(25:10 - 25:29)

Donc, je n'insisterai pas beaucoup parce que il frappe donc l'hypertension. L'hypertension portale fait partie des chapitres que vous allez avoir l'année prochaine dans la pathologie digestif. Et il y a l'espino-mégalie d'origine infectieuse.

(25:29 - 25:45)

Là, on tisse toujours devant l'espino-mégalie. C'est le risque que le patient présente une septicémie et en particulier une endocardite bactérienne. Donc, il faut savoir les rechercher, en particulier chez les patients à risque, chez les patients fébriles.

(25:46 - 26:11)

Il y a aussi les infections virales, la mononucléose infectieuse, la cytomégalovirus, une éventuelle

primo infection virale. C'est pour ça qu'il faut savoir rechercher les facteurs de risque de ces infections. Une tuberculose splénique, la localisation splénique de la tuberculose est rare, mais il est possible et souvent, elle est associée à d'autres localisations, notamment ganglionnaire ou hépatite.

(26:11 - 26:34)

Il faut rechercher aussi une syphilis. Donc, l'espinomégalie d'origine parasitaire, on a le paléisme. Il faut toujours y penser devant une fièvre prolongée ou un patient qui a une rate splénomégalie avec notion de séjour dans un pays d'endémie.

(26:34 - 26:55)

Il faut savoir que la splénomégalie peut se voir aussi bien dans les premiers accès de paléisme comme dans les formes chroniques. C'est pour ça que même un séjour très lointain doit faire penser au paléisme. Il y a aussi la leishmaniose qui peut s'accompagner de splénomégalie, mais dans un contexte évocateur.

(26:55 - 27:18)

Généralement, c'est dans un contexte fébrile avec des adénopathies, voire une épatomégalie avec parfois des lésions cutanées. Et généralement, on arrive à mettre en évidence. On va la suspecter selon le contexte, mais on met en évidence au niveau de la le parasite au niveau du.

(27:18 - 27:30)

Il y a les belles, la la bilarziose. Là aussi, il faut chercher le séjour. Le qu'ici date explique qu'il sera responsable d'une lésion quistique au niveau à au niveau de la rate à l'échographie.

(27:31 - 27:53)

Il y a une splénomégalie en rapport avec certaines maladies disimmunitaires, notamment avec la sarcoldose, lupus, etc. Et parfois, on a des splénomégalias isolées. Et c'est l'étude histologique après de la rate après une splénomégalie qui peut poser le diagnostic.

(27:53 - 28:53)

Ça se voit essentiellement dans les splénomégalias surcharge avec localisation splénique isolée et dans certains splénomégalias d'origine tumorale. Le traitement, il dépend de l'étiologie et en cas de réalisation d'une splénectomie, soit à but thérapeutique ou diagnostique ou en cas d'urgence, lorsqu'on a une rupture de la splénomégalie, il faut penser à proposer aux patients un vaccin contre le pneumocoque et une pénicillinothérapie préventive. Donc, la splénomégalie, c'est un signe clinique fréquent qui peut révéler des pathologies variables et c'est pour ça qu'il faut mener l'enquête étiologique adaptée, mais surtout, surtout identifier les étiologies urgentes

qui engagent le pronostic vital du patient, notamment l'endocard.

(28:54 - 28:54)

Je vous remercie.